

Consulta

NS

ZILMA ANDREIA RODRIGUES RICCI

IDADE: 56 PESO: 92 ALTURA: 160 PROFISSÃO: Prof. Artes - Apes.
 SINTOMAS: Cansaço e sonolência diurna / mmII edema
 QUEIXAS: Tontura (ansiedade / Hipotireoidismo)
 MEDICAMENTOS: Omeprazol / Levoide / Pradaxa / Sertrolina / Glicage (2x) / Celoski / Desogestrel / Forxiga / Simvastatina
 MÉDICO: Dr. Bruno
 EXERCÍCIO FÍSICO: 3x semana - Treino funcional - 30' cardio.
 HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: N JANTAR: 22
 HORA QUE DORME: 22 HORA QUE ACORDA: 6:45 (Acad) 8:30 (outro)
 COCHILHO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
 BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA NÃO
 FUMO () SIM () MAÇO/DIA NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1 a 2x
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
 OVERLAP: não MALLAMPATI: III (+) IAH: 24. SPO2: 98%
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS / DM / Dançell.
 CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA
 HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:
 COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA () CARDÍACA Fibrilação
 (S) ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS Marcapasso + Tricla
 Dor no corpo
 12/12/23 21/12/2023 início

03/01/2024 P= 7 cm H2O
 IAH = 0,5 x/h
 m. de uso = 8h49min
 fuga 18/11min
 Sem adaptada
 desperta a noite
 duração 30 → 40 min

Nome: ZILMA ANDREIA RODRIGUES RICCI

Data de Nascimento: 20-1-1967

IMC: 35,94

Sexo: Feminino

Data do exame: 01-11-2023

Peso: 92 kg

Altura: 1,60 m

Médico: DR. BRUNO NOGUEIRA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 01-11-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 433,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 28,5 e 83,5 minutos. O tempo total de sono foi de 385,5 min, eficiência de 88,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,3%; estágio N2: 61,0%; estágio N3: 16,1%; sono REM: 20,6%. O índice de despertares foi de 14,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 24,0/hora, sendo 17 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 134 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 78%, permanecendo 4,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 60 - 60 bpm e NREM de 60 - 74 bpm.

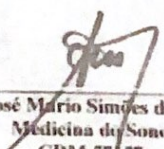
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (07), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 24,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=78%);
5. latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (2,8/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57